

警惕氢化可的松与抗菌药物相互作用导致双硫仑样反应

王强 孙予兰

(陕西航天医院, 陕西 西安 710025)

【摘要】 双硫仑反应临床并不少见。表现缺乏特异性, 临床知晓相对不足, 容易漏诊误诊, 误治。药物与药物引起者更易于误诊漏诊和误治, 以下病例提示双硫仑反应诱因的多样性。应引起临床重视。

【关键词】 氢化可的松与抗菌药物相互作用; 双硫仑反应

Alert cortisol and antimicrobial drug interactions causing disulfiram like reaction WANG Qiang, SUN Yu-lan.
Shaanxi aerospace hospital in xi'an 710025

【Abstract】 Disulfiram like reaction is not a rare In Clinical Center. The lack of specificity performance, clinical knowing relatively insufficient, easily misdiagnosed as the diagnosis, the disease. Drugs and drug causers are easy to be misdiagnosed the diagnosis and the disease, the following cases hint at the diversity of disulfiram like reaction. It should cause clinical attention.

【Key words】 Cortisol and antimicrobial drug interactions; Disulfiram like reaction

双硫仑是一种戒酒药物, 化学名称为二硫化四乙基秋兰姆, 服用该药者即使饮用少量的酒或含酒精的饮料身体即会产生面部潮红, 头痛, 腹痛, 出汗, 心悸, 呼吸困难等症状。有部分药物也可以引起双硫仑样反应, 如头孢类抗生素, 咪唑类抗生素, 部分降糖药物等。双硫仑反应常见于服用上述药物患者, 饮用含酒精饮料后出现上述症状。常被误诊为急性冠脉综合征等病, 但是双硫仑反应临床知晓相对不足, 报道并不多, 极容易漏诊误诊。举一病例如下让我们再次认识双硫仑反应。

病例: 陕西航天医院内 2 科患者, 病案号 26659。王某某, 男, 70 岁, 住西安灞桥华清路 5 号。于 2010 年 11 月 17 日 11 时因为“发作性胸闷、气短 1 年, 咳嗽、咳痰 2 天”入院。入院前 1 年无原因而出现发作性胸闷、气短, 咳嗽、咳痰, 晨起及夜间会加重, 受凉后会加重, 曾在外院查支气管激发试验阳性, 确诊为“支气管哮喘”并予以相应药物治疗后症状缓解。2 天前受凉后上述症状再次出现, 伴有咳吐白色泡沫样痰夜间难以平卧但无双下肢水肿。伴有活动后气喘, 胸闷等症状, 休息后症状可缓解。无鼻塞、流涕, 无显著乏力。自服阿莫西林胶囊(量不详)无缓解而来本院。既往冠心病史 3

年, 否认高血压史。否认药物及食物过敏史。入院查体: 体温: 36.0℃ 脉搏: 92 次/分 呼吸 20 次/分 血压 118/66 mmHg。神志清楚, 精神差, 端坐呼吸, 皮肤无紫绀, 鼻通畅, 咽无充血红肿, 扁桃体不大, 气管居中, 呼吸动度对称, 肺叩诊过清音, 双肺呼吸音偏低, 呼气相延长, 双肺下满布哮鸣音。心前区无隆起, 无异常搏动, 心界不大, 心音稍弱, 心率 92 次/分, 律齐, 第二心音稍亢 A2>P2, 各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。肝脾未及, 双下肢轻度凹陷性水肿。入院诊断: 1. 支气管哮喘 2. 慢支急性发作 肺源性心脏病 心功能 III 级 3. 冠心病 心肌缺血。入院后予以抗感染解痉支持对症等治疗。予以头孢哌酮舒巴坦钠 2.0, 2 次/日静滴; 氨溴索 30 mg, 2 次/日; 氨茶碱 0.25/日, 静滴; 川芎嗪 160 mg/d, 静滴; 沙丁胺醇气雾剂 1 次, 2-4 次/日; 布地奈德吸入剂 1 喷, 2-4 次/日; 氢氯噻嗪片 12.5 mg/日; 螺内酯 20 mg/日。持续吸氧等措施。入院当日中午临时予以 5% 葡萄糖 250 mL 加氢化可的松 100 mg (4 支×5 mL) 静滴, 之后出现一过性心慌、气短, 喘息加重, 心动过速, 当时认为是患者自身哮喘症状反复, 予以吸入支扩剂至下午逐渐症状逐渐减轻。第二日重复入院治疗并静滴氢化可的松 100 mg,

作者简介: 王强, 男, 毕业于陕西中医学院及西安交大医学院, 陕西航天医院 内科主治医师, 从事临床工作近 20 年, 对内科疾病有一定经验。

患者再次出现喘息症状且症状加重,心慌、气短,端坐呼吸,喉中痰鸣,查体:呼吸 28 次/分,脉搏 105 次/分,体温 36.7℃,血压 118/74 mmHg,精神焦虑,急性病容,颜面肤色发红,口鼻出气有酒精气味,用力端坐呼吸,双肺呼吸音偏低,呼气相延长,双肺满布哮鸣音伴痰鸣,较入院时明显加重,心律齐,其余不变。症状 2 次反复出现,经过平喘对症抗感染等治疗病情没有缓解而且加重了,临床没有满意解释,科内展开反复讨论,后认为患者口鼻呼出气有酒精气味应引起重视,但是追问病史患者并不善于饮酒,且近期从未饮酒。分析并查找资料,后认为患者入院前后使用了阿莫西林胶囊及抗生素头孢哌酮舒巴坦钠,之后再使用氢化可的松针剂,关键是氢化可的松制剂是以酒精为溶媒,酒精进入身体后竞争性抑制乙醛脱氢酶活性,诱发双硫仑反应,可能引起上述症状。立即按双硫仑反应处理,停氢化可的松,心电监护,监测生命体征,吸氧,多次予以葡萄糖及辅酶 A 维生素 C 等液体。并吸入支气管扩张剂沙丁胺醇气雾剂 1 欵及布地奈德吸入剂 1 喷,持续约 4-5 小时后症状逐渐缓解,患者可以较自由行动。次日停氢化可

的松制剂,其余治疗不变,患者未再发生类似症状,共治疗 9 天,痊愈出院。

总结:出现双硫仑样反应患者其体内乙醛脱氢酶活性被抑制,乙醛聚集,后者具有心脏毒性和致心律失常作用,可提高交感神经兴奋性,导致心率加快耗氧增多,缩短舒张期等,并减少冠脉流量,引起心电图及心肌酶改变。双硫仑代谢产物二乙基二硫基氨基甲酸酯可减少血管活性物生成,导致出现低血压,气短,胸闷,呼吸困难,心率加快,面部潮红,乏力,呕吐,视物模糊等症状。严重的导致心律失常或血容量不足,低血压,未及时救治时可能会右严重后果。及时治疗预后良好。目前双硫仑反应无相应的专家共识及相关指南,诊断主要依据病史症状体征。目前应用头孢类抗菌素非常广泛,但是双硫仑反应临床知晓相对不足,容易漏诊误诊,误治。笔者临床遇见多例双硫仑反应,但本例双硫仑反应患者是由药物与药物引起者,药物制剂中含有酒精者临床少见,更易误诊,误治,应当引起临床重视。实践中应当注意询问患者的饮酒史服药史。